核心精讲

其它颈胸部疾病

性感认识：有些外科考纲内容已总结在内科中

一、肋骨骨折

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
00:00:42--00:12:05

1.临床表现

①第4–7肋最易骨折（死期到了）

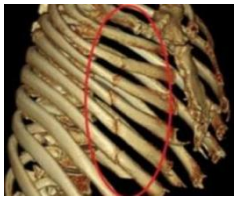
②胸痛、呼吸浅快、断端骨擦音和骨擦感、胸廓畸形及挤压试验阳性、肺部感染和不张、血气胸、肝脾损伤（腹部B超）

③多根多处肋骨骨折：在≥2根相邻肋骨各自发生≥2处骨折，称为连枷胸

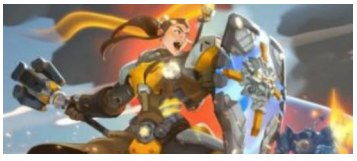
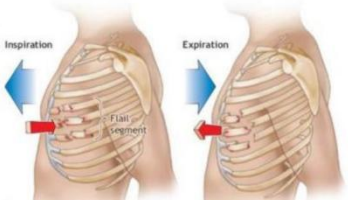
《诊断学》：抑制性呼吸是因胸部剧痛致吸气突然停止（会呼吸的痛），主要见于胸部严重外伤、肋骨骨折、急性胸膜炎、胸膜恶性肿瘤

「理顺知识点」

- 骨折特有体征：局部畸形、异常活动、骨擦音和骨擦感
- 低位肋骨骨折→常规做腹部B超（目的是诊断肋骨骨折合并的肝脾损伤）

胸廓挤压试验

2.控制疼痛、早期活动、物理治疗

（1）非多根多处：胸带固定

（2）多根多处

①胸壁软化范围小（无明显反常呼吸运动）：胸带固定

②胸壁软化范围大（有明显反常呼吸运动、纵隔扑动）：气管内插管呼吸机正压通气、切开复位内固定

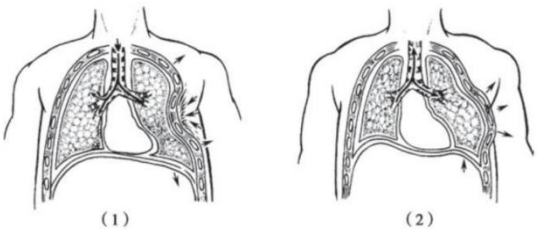


图 27-1　连枷胸，胸壁软化区的反常呼吸运动
(1)吸气　(2)呼气

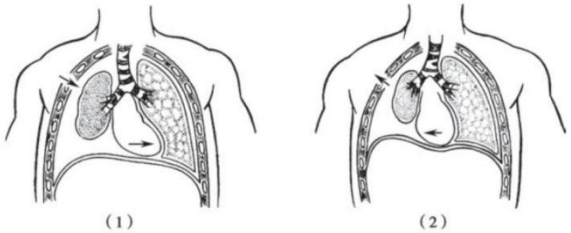


图 27-2　开放性气胸的纵隔扑动
(1)吸气　(2)呼气

「理顺知识点」

- 开放性气胸：患侧胸膜腔与外界相通→患侧胸腔负压消失，但健侧胸腔负压仍存在→吸气时胸腔负压更负→吸引纵隔移向健侧→呼气时回到正中位（纵隔摆动）
- 多根多处肋骨骨折和开放性气胸的本质都是两侧胸膜腔压力不平衡→纵隔摆动「多开摆」
- 反常呼吸运动：局部胸壁失去肋骨支撑而软化，在自主呼吸时出现反常运动，即吸气时软化区胸壁因胸腔负压而内陷，呼气时突出
- 骨科在进行固定时，一般优先考虑外固定（不用做手术），当外固定搞不定时就考虑做手术→切开复位内固定

二、创伤性窒息

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
00:12:05--00:14:45

①钝性暴力挤压胸部→瞬间声门紧闭→胸内压骤↑→上腔静脉血液逆流→上半身广泛皮肤黏膜毛细血管淤血及出血→针尖大小的瘀斑

②对症处理（多在2-3周后出血自行吸收消退）纸老虎

「理顺知识点」

- 钝性暴力挤压胸部→瞬间声门紧闭→胸内压骤↑（可变为正压）→上腔静脉血液逆流（上腔静脉无静脉瓣易发生倒流）→上半身广泛皮肤黏膜毛细血管淤血及出血 →针尖大小的瘀斑

三、纵隔肿瘤

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
00:14:45--00:22:42

（前鸡胸胸后发神经）

①前纵隔：畸胎瘤和皮样囊肿、胸腺瘤（前上纵隔）、胸骨后甲状腺肿（前上纵隔）

②中纵隔：心包囊肿、支气管囊肿、淋巴瘤

③后纵隔：神经源性肿瘤如神经鞘瘤（哑铃形）

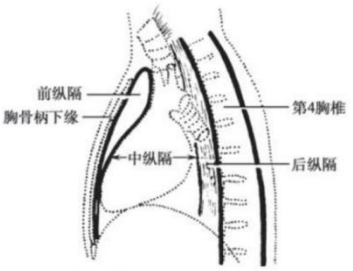


图 31-1　纵隔临床解剖分区

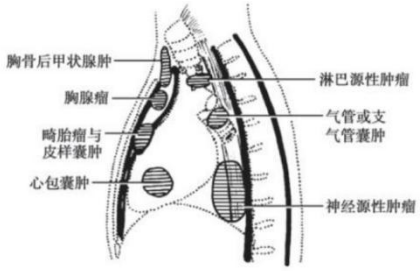
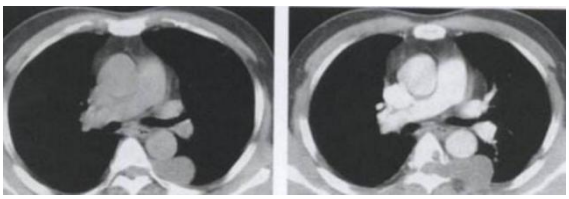


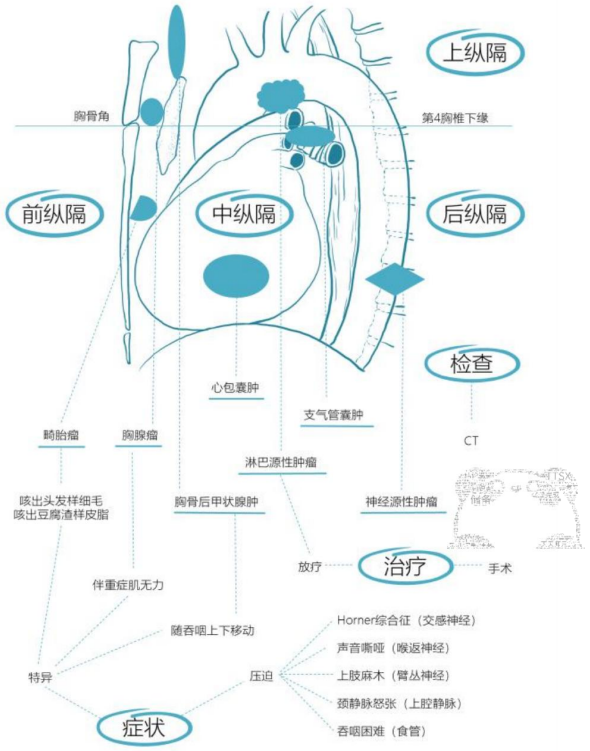
图 31-2　纵隔肿瘤好发部位



四、急诊开胸探查

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
00:22:42--00:23:35

进行性血胸、胸腹联合伤、穿透性膈肌损伤、创伤性膈肌破裂或膈疝、休克、心脏压塞、严重气管内出血如严重穿透伤或火器伤（金莲哥、休心气）



「理顺知识点」

• Horner综合症：肺上沟瘤、甲状腺癌、甲状腺手术后、食管癌、纵隔肿瘤、臂丛N根旁撕脱伤

真题解析·其它颈胸部疾病

外科　其他颈胸部疾病&胃肿瘤&腹腔感染
00:23:35--00:28:10

1.2014N84A以下胸部损伤须考虑手术探查的是

A.胸腹联合伤　　金莲哥、休心气

B.胸部爆震伤　　是面的问题，不是点的问题，探查无用

C.创伤性窒息　　纸老虎

D.胸骨损伤

2.2015N175X女性，28岁。车祸伤及右胸1小时。查体：P96次/分，R24次/分，BP140/95mmHg。右前胸未见反常呼吸运动，局部肿胀、压痛明显，右肺呼吸音降低，X线胸片示右侧8、9肋骨后端骨折，恰当的处理措施有

A.腹部B超　　低位肋骨骨折→常规做腹部B超（目的是诊断肋骨骨折合并的肝脾损伤）

B.胸带固定

C.牵引固定

D.镇静止痛

　　答案：1-2 A ABD

3.2018N61A出现反常呼吸运动的胸部损伤为

A.开放性气胸

B.闭合性气胸　　多开摆

C.张力性气胸

D.多根多处肋骨骨折

4.2020N63A以下胸部创伤性疾病中，一般采取非手术治疗的是

A.血胸

B.张力性气胸

C.开放性气胸

D.创伤性窒息

5.2022N62A以下有关创伤性窒息的病理生理改变，错误的是

A.瞬间声门紧闭

B.小支气管和肺泡破裂　毛细血管

C.胸内压骤升

D.上腔静脉系统血逆流

　　答案：3-5 D D B